

Terapia grupowa w AvPD

Paradoksalnie **najtrudniejsza do rozpoczęcia, ale $d \approx 0,7$** . Naturalna ekspozycja + walidacja rówieśnicza + modelowanie = lek na izolację, której terapia indywidualna nie adresuje bezpośrednio.

CZAS: 12 min 12-20 sesji **ŹRÓDŁO:** Alden (1989, RCT); Kocovski i wsp. (2009); Yalom (2005)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz *cztery mechanizmy* działania grupy (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz **paradoks ekspozycji indywidualnej** — dlaczego sama nie wystarcza (sekcja 02). **3** · Sprawdzisz *swoją gotowość* do wejścia w grupę (sekcja 03). **4** · Poznasz **warunki dobrej grupy** — strukturalność, zamknięta, 6-10 osób (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Terapia grupowa jest **szczególnie skuteczna** w AvPD, choć paradoksalnie *najtrudniejsza* do rozpoczęcia — sam fakt wejścia do grupy jest już ekspozycją wysokiego poziomu. Alden (1989, RCT): grupowa CBT osiąga **$d = 0,6-0,8$** w AvPD i *specyficznie* redukuje izolację, której terapia indywidualna *nie* adresuje bezpośrednio. Grupa działa przez trzy główne mechanizmy (Yalom 2005): **uniwersalność** („nie jestem sam z tym”), **uczenie interpersonalne** (feedback w czasie rzeczywistym), **spójność grupowa** (doświadczenie przynależności *korygujące* schemat izolacji). Najlepszy moment: po **6-12 miesiącach** pracy indywidualnej, gdy pacjent ma już podstawowe narzędzia i może wytrzymać dyskomfort wejścia. Późniejsze adaptacje obejmują MAGT (*Mindfulness and Acceptance-Based Group Therapy*, Kocovski i wsp. 2009).

01 Cztery mechanizmy działania grupy

1 · NATURALNA EKSPOZYCJA

Bycie w grupie **jest** ekspozycją. Codziennie, przez całą sesję. Bez sztucznej hierarchii — wszystko, co w terapii indywidualnej trzeba zaplanować, dzieje się *samo*.

2 · NORMALIZACJA

„Inni **też** się boją”. Pacjent słyszy własne myśli w ustach innych — i pierwszy raz widzi je jako *schemat*, nie prawdę. Uniwersalność (Yalom).

3 · FEEDBACK RÓWIEŚNICZY

„Jak mnie widzicie?” — odpowiedź *dużo* lepsza niż samoocena. Walidacja przez kogoś, kto sam doświadcza wstydu, działa silniej niż walidacja terapeuty („on/ona jest płatna”).

4 · MODELOWANIE

Obserwacja, *jak inni* radzą sobie z lękiem w czasie rzeczywistym. Inny pacjent mówi coś osobistego — uczę się, że to **możliwe** i że *nic strasznego* się nie dzieje.

Klucz: grupa to *żywe laboratorium* — ekspozycja na różne osobowości, naturalny feedback, walidacja przez rówieśników („też tak mam”). Doświadczenie przynależności **korygujące** schemat izolacji — coś, czego terapia indywidualna z natury *nie* dostarcza.

02 🎯 Pułapka „świetny w gabinecie, samotny w życiu”

TYLKO INDYWIDUALNA
50 sesji z jedną osobą — nadal brak znajomych

INDYWIDUALNA + GRUPA
narzędzia z indywidualnej + transfer w grupie

NAJLEPSZY MODEL: 6–12 MIES. INDYWIDUALNEJ + GRUPA RÓWNOLEGLE
indywidualna daje przygotowanie, grupa daje doświadczenia korygujące

Pułapka safe behavior: terapia indywidualna może stać się kolejnym zachowaniem zabezpieczającym — pacjent ćwiczy umiejętności z jedną, bezpieczną osobą, ale nie przenosi tego na realne grupy. Po 50 sesjach: świetnie funkcjonuje w gabinecie, a wciąż **nie ma znajomych**. Grupa wymusza transfer.

03 ✎ Moja gotowość do wejścia w grupę

ILE MIESIĘCY W TERAPII INDYWIDUALNEJ?

— optymalnie ≥ 6 mies. przed grupą

CO MNIE NAJBARDZIEJ PRZERAŻA W GRUPIE?

— mówienie, milczenie, ocena?

CO MÓGLBYM/-ABYM ZYSKAĆ?

— uniwersalność, feedback, modelowanie

PLAN B NA TRUDNY MOMENT

— co zrobię gdy poczuję chęć ucieczki?

04 💡 Warunki dobrej grupy dla AvPD

OPTIMUM KLINICZNE

Zamknięta grupa, **6–10 osób**, prowadzona przez **dwoch** terapeutów, **12–20 sesji**. Strukturalna agenda, jasne reguły, stopniowane zadania. Praca z konkretnym schematem.

CZEGO UNIKAĆ

Otwarte grupy wsparcia (rotacja przeciąża), anonimowe warsztaty bez follow-upu, grupy bez struktury (każdy mówi, co chce), grupa >15 osób, jeden terapeuta na grupę.

Klucz: Alden 1989: grupowa CBT specyficznie redukuje izolację, której indywidualna *nie* adresuje. Yalom (2005): **uniwersalność, uczenie interpersonalne, spójność grupowa** — trzy najsilniejsze czynniki terapeutyczne grupy. W AvPD grupa działa jako żywe *laboratorium* — naturalna ekspozycja, feedback rówieśniczy, modelowanie. **Warunek skuteczności:** grupa *strukturalna*, zamknięta, 6–10 osób, 12–20 sesji. Losowa grupa wsparcia często *szkodzi* w AvPD (przeciążenie). Najlepszy moment: po 6–12 miesiącach pracy indywidualnej — pacjent ma już podstawowe narzędzia i może wytrzymać dyskomfort wejścia.